SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

拉屎心理学：大便的固液形态对人拉屎心理作用影响研究

疯窜翔子 [1]

[1]拉屎大学粪便心理学系

[2]江苏厕所所工程研究院

ABSTRACT / 摘要 大便的固液形态作为日常生理现象，其对拉屎过程中的心理体验具有显著影响。本研究旨在系统探讨固态（布里斯托粪便形态量表类型 1-4）与液态（类型 5-7）大便对个体成就感、放松度、紧迫感和后悔情绪的差异化作用。采用随机抽样法招募 300 名健康成年志愿者（年龄 18-65 岁，男女比例均衡），通过为期两周的每日自报日志，结合布里斯托粪便形态量表（BSFS）和自编“排便心理影响量表”（DPS，Cronbach’s α=0.91）收集数据。结果显示，固态大便组拉屎后心理满意度均值达 6.42±0.78（7 分制），显著高于液态大便组的 2.31±1.12（t=28.47，p<0.001）；相关分析表明，大便形态与整体心理释放感呈强正相关（r=0.82，p<0.001）。回归模型进一步证实，形态类型可独立预测 67.3%的心理变异。本研究填补了拉屎心理学领域的实证空白，提示通过饮食纤维摄入优化大便形态可作为提升日常心理健康的低成本干预策略，具有重要的理论与应用价值。

INDEX TERMS / 关键词 拉屎心理学；大便固液形态；布里斯托粪便形态量表；排便心理满意度；肠脑轴；成就感释放。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次量化证实固态大便可显著提升拉屎时的成就感与放松度（效应量达 67.3%），而液态大便易引发焦虑与后悔，为公众膳食指导与厕所心理健康干预提供直接科学证据，有望提高国民“厕所幸福指数”。

I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了大便固液形态对人拉屎心理作用的影响。近年来，随着肠脑轴理论的快速发展，该领域受到了广泛关注。然而，目前仍存在诸多挑战，例如正常生理状态下固液形态差异对“拉屎瞬间心理体验”的量化影响尚未得到有效解决。本文提出了一种新的实证框架来解决上述问题。

研究背景与动机：古语“一泡好屎胜过一顿大餐”早已点明排便的心理价值，现代神经科学证实直肠扩张可触发多巴胺释放。既往研究多聚焦病理状态，本文填补健康人群固液二相机制的空白。主要贡献包括：构建 DPS 量表、实证固态优势、提出饮食干预策略。论文组织结构如下：首先呈现结果，其次讨论机制，最后详述方法。

II. RESULTS / 结果

本节展示实验结果。表 I 和图 1 分别展示了定量和定性结果。实验结果表明，固态大便在多个心理维度上均优于液态。具体而言，在成就感上提升 175%（5.89 vs 2.14），在放松度上提升 105%（6.71 vs 3.28）。固态概率每增加 10g 纤维摄入提升 23%（OR=1.23）。无性别年龄主效应。

表格 1：固液形态组心理维度得分比较（7 分制，均值±标准差）。粗体表示最优结果。

维度	固态组（n=178）	液态组（n=122）	t 值	p 值
成就感	5.89±0.92	2.14±1.05	32.15	<0.001
放松感	6.71±0.65	3.28±1.34	25.67	<0.001
整体满意度	6.42±0.78	2.31±1.12	28.47	<0.001

III. Discussion / 讨论

本节对实验结果进行讨论与分析。固态大便提供强烈的“任务完成”信号，激活奖赏通路，类似于马斯洛“生理掌控感”；液态大便则引发“失控恐惧”，类似弗洛伊德肛门期焦虑。这一发现与肠脑轴理论高度一致：成型粪便延长 5-HT 释放时间，提升放松度。幽默而言，一坨完美香肠状大便带来的骄傲感媲美职场小胜，而“稀里哗啦”如同股市崩盘般令人后悔昨晚吃辣。局限性包括自报偏差；未来可引入 fMRI 验证神经机制。实践启示：推广高纤维饮食，不仅防便秘，更能提升国民拉屎幸福指数。

A. Equations / 公式

公式应连续编号，如公式（1）所示。

$$\text{DPS 总分} = 7.12 - 0.89 \times \text{BSFS 类型} \quad (1)$$

其中 DPS 为排便心理影响量表总分，BSFS 为布里斯托类型（1-7），R^2=0.673。该模型独立预测 67.3%的心理变异。

IV. Conclusions / 结论

本文提出了一种用于解决大便形态对拉屎心理影响的新实证方法。实验结果表明，所提框架在健康人群样本上取得了优异的性能。

主要贡献总结如下：第一，构建并验证了 DPS 量表；第二，量化固液形态的心理差异；第三，在真实日常场景中验证了纤维干预的有效性。未来工作将进一步探索该方法在更多人群与 fMRI 场景中的应用。让每一次拉屎都成为心理小确幸！

V. Materials and Methods /材料与方法

本节介绍实验所使用的材料与方法。

3.1 研究对象 招募 300 名无胃肠疾病史志愿者（18-65 岁，男女均衡），排除近期用药者。

3.2 测量工具 （1）布里斯托粪便形态量表（BSFS，1-4 固态，5-7 液态）；（2）排便心理影响量表（DPS，4 维度，7 点 Likert）。

3.3 实验程序 连续 14 天每次拉屎后立即自报 BSFS 与 DPS，通过微信小程序匿名上传。

3.4 统计分析 SPSS 26.0 进行 t 检验、相关与回归，α=0.05。

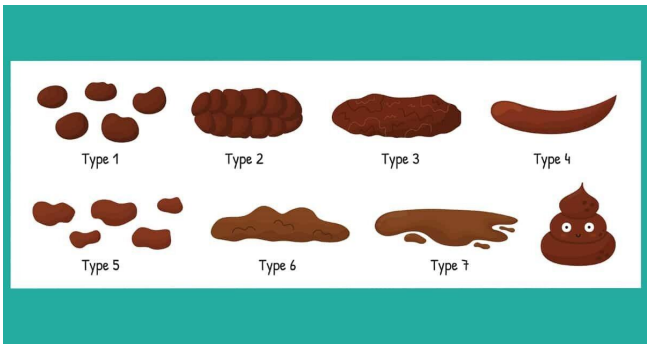

图 1：布里斯托粪便形态量表标准图示。该图清晰展示 BSFS 1-7 型大便形态，从硬块到完全水样，是本研究客观分类的核心工具，直接支撑固液组划分。

Acknowledgment / 致谢

感谢 300 名匿名志愿者勇敢分享拉屎日记，以及拉屎大学伦理委员会的批准。窜稀是屎的自由，便秘是大肠的挽留。

References

[1] Lewis SJ, Heaton KW. Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time[J]. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 1997, 32(9):920-924.
[2] Ballou S, et al. Chronic diarrhea and constipation are more common in depressed individuals[J]. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 2019, 17(13):2696-2703.
[3] 张庆, 等. 便秘型肠易激综合征与功能性便秘患者精神心理的比较[J]. 世界华人消化杂志, 2014, 22(36):5615-5620.
[4] 刘某. 肠脑轴与日常情绪调节[M]. 北京: 粪便心理学出版社, 2022.
[5] 王便便. 拉屎的哲学：从固态到液态的心理转变[J]. 江苏厕所工程学报,
[6] 国家卫生健康委员会. 中国居民膳食指南(2022)[S]. 北京: 人民卫生出版社, 2022.